Cancer du poumon et TEP au FDG

À RETENIR

- 1re cause de décès par cancer ; facteurs : **tabagisme ++**, exposition professionnelle ; ADK et carcinome épidermoïde les plus fréquents.
- Avidité de l'ADK = groupe hétérogène : les formes **mucineuses** (invasives) sont **peu avides**.
- La TEP intervient aux différents stades de la maladie, **mais pas pour le dépistage ni la surveillance**.
- Caractérisation du nodule : **80 %** des nodules avides sont des cancers.
- Bilan d'extension (ESMO) : rôle **majeur**, remplace le scanner ; mais pas pour le cerveau (risque de M+ cérébrale → **IRM**) ; préférer une TEP avec TDM injectée.
- Staging ganglionnaire « N » : facteur pronostique +++ avec une excellente **VPN**.
- Évaluation thérapeutique : critères **PERCIST** ; pièges de l'immunothérapie (pseudo-progression, effets secondaires immuno-induits).

I. Introduction

- **1re cause de décès par cancer**.
- Facteurs de risque : **tabagisme ++**, exposition professionnelle.
- Adénocarcinome (ADK) et carcinome épidermoïde les plus fréquents ; cancer à petites cellules…
- **Avidité de l'ADK** = **groupe hétérogène** :
  - ADK *in situ* ;
  - ADK à invasion minime ;
  - ADK invasif — dont la forme **mucineuse** (peu avide).

II. Place de la TEP

1. Caractérisation du nodule.
2. Bilan d'extension.
3. Planification de la RTE (radiothérapie externe).
4. Évaluation thérapeutique.
5. Suspicion de récidive.
6. TEP impliquée dans l'algorithme thérapeutique.

NB — La TEP intervient aux **différents stades de la maladie**, mais **pas pour le dépistage ni pour la surveillance**.

1. Caractérisation du nodule

- **80 %** des nodules avides sont des cancers.

2. Bilan d'extension

- Selon l'**ESMO** : la TEP/TDM joue un **rôle majeur** dans le bilan d'extension ; elle **remplace le scanner**.
- Pas pour le bilan d'extension avec risque de **métastase cérébrale** → **IRM**.
- Préférentiellement : TEP avec **TDM injectée**.
- Intérêt dans le **staging ganglionnaire « N »** de la TNM : facteur pronostique +++, avec une excellente **VPN** (valeur prédictive négative).
- M1 : [non complété dans les notes].

3. Bilan (planification) de la RTE

- Radiothérapie **stéréotaxique** (si N+, on ne la fait pas).

- Faire une RTE **ciblée et sélective**.

4. Évaluation thérapeutique

- Critères **PERCIST**.
- Répondeur rapide ou lent.
- Sous immunothérapie : **pseudo-progression** = volume tumoral ↓ puis ↑ **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement ↑ initiale puis ↓ (réponse retardée)*.
- Effets secondaires **immuno-induits**.

5. Guide la biopsie

6. Suspicion de récidive

7. Algorithme thérapeutique

La TEP est impliquée dans l'algorithme thérapeutique.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle forme d'adénocarcinome pulmonaire est peu avide du FDG ?	La forme invasive mucineuse.
2. Quel pourcentage des nodules avides correspond à un cancer ?	80 %.
3. Dans quelles situations la TEP n'est-elle pas indiquée dans le cancer du poumon ?	Dépistage et surveillance ; et pour les métastases cérébrales (→ IRM).
4. Intérêt de la TEP dans le staging N ?	Facteur pronostique +++ avec une excellente valeur prédictive négative.
5. Quels critères pour l'évaluation thérapeutique ?	PERCIST.
6. Que recommande l'ESMO pour le bilan d'extension ?	TEP/TDM (de préférence avec TDM injectée), qui remplace le scanner.